Mémo - Partie 2 : Analyse du partage des données (RGPD) et recommandation

Contexte : Un laboratoire pharmaceutique nous propose de meilleures conditions tarifaires en échange d'un accès complet aux données de la pharmacie, sous la forme d'un export régulier (incluant notamment les horaires précis des ventes). L'objectif de cette partie est d'analyser la faisabilité de cette proposition d'un point de vue légal, éthique et stratégique.

1. Nature des données et réglementation (RGPD) Le fichier des ventes que nous traitons ne contient pas que des données commerciales classiques (comme la vente de paracétamol ou d'ibuprofène). Il inclut également des ventes d'anxiolytiques (catégorie N05B) et de somnifères (catégorie N05C). Au sens du RGPD, il s'agit de données de santé, considérées comme particulièrement sensibles et soumises à un cadre strict. Le partage de ces informations nécessite une prudence absolue. Le fait que le fichier ne contienne aucun nom ne suffit pas : pour le RGPD, une donnée reste personnelle dès qu'elle permet d'identifier quelqu'un, même indirectement. Des données de santé sont par principe interdites de traitement, sauf exceptions strictes (article 9 du RGPD). Un partage à des fins commerciales n'entre dans aucune de ces exceptions.

2. Le risque majeur : la ré-identification des patients La proposition actuelle prévoit un export des données comprenant l'horaire précis de chaque vente. C'est ici que se trouve le risque principal. En effet, même si les noms des patients ne figurent pas dans le fichier, l'ajout de l'horaire permet une ré-identification facile par déduction. *Exemple concret :* Si le fichier indique qu'une boîte de somnifère a été vendue un mardi à 8h02, une personne présente dans la pharmacie à ce moment-là, ou connaissant un peu les habitudes locales, pourrait facilement déduire l'identité de l'acheteur. Plus on affine le niveau de détail (mois > semaine > jour > heure), plus le risque de fuite de la vie privée augmente. Nos données le confirment : les somnifères (N05C) ne sont vendus que 32 % des jours, et en moyenne moins d'une boîte par jour (0,6). Dans le fichier horaire, une vente de somnifère est donc le plus souvent la seule de sa journée, voire de sa semaine : elle est quasiment unique, et donc facilement attribuable à une personne.

3. Enjeux déontologiques et stratégiques Au-delà de l'aspect purement légal (RGPD), accepter cet accord pose plusieurs problèmes pour la pharmacie :

- Secret professionnel : Le pharmacien est tenu au secret professionnel et au respect du code de déontologie. Permettre à un tiers de déduire l'état de santé de ses patients est une ligne rouge (Code de la santé publique, article R.4235-5 ; sa violation est sanctionnée par l'article 226-13 du Code pénal).
- Risque d'image : Si les patients apprennent que les données de leurs traitements, même "anonymisées", sont partagées avec un laboratoire à des fins commerciales, la perte de confiance serait immédiate et désastreuse pour la pharmacie.
- Indépendance de la pharmacie : Accepter cet accord risque de créer une dépendance financière envers ce seul laboratoire, ce qui pourrait biaiser les conseils donnés au comptoir et nuire à l'indépendance de l'équipe officinale.

4. Recommandation finale Au vu des risques légaux (RGPD), déontologiques et commerciaux, la recommandation est de refuser l'accord sous sa forme actuelle, et plus particulièrement de refuser tout partage du fichier horaire.

Si le propriétaire souhaite tout de même poursuivre les négociations avec ce laboratoire, voici un cadre acceptable :

- Ne partager que des données fortement agrégées (par exemple, des totaux de ventes par mois), ce qui empêche toute ré-identification par l'horaire.
- Exclure totalement les anxiolytiques (N05B) et les somnifères (N05C) du partage, même en données mensuelles.
- Mettre en place un contrat très encadré, en sollicitant l'avis d'un juriste spécialisé en santé ou de l'Ordre des pharmaciens pour valider les clauses avant signature.
- Le contrat doit fixer l’usage autorisé des données, interdire leur revente et leur croisement avec d’autres sources, et prévoir leur suppression en fin de contrat.
- Garder en tête que ces données ont une valeur commerciale pour le laboratoire : c’est un argument de négociation, et une remise sur les prix ne doit pas se payer avec la confiance des patients.